

22221870922 DN693

CARMEN DEJA MEDEIROS BARBOSA	
SINTOMAS / QUEIXAS	<i>Canseira / Soneolência / AAS /</i>
MEDICAMENTOS	<i>Ratimadonone / Ara 2 / Anticoagulante</i>
HORA QUE DORME:	<i>22:30</i> HORA QUE ACORDA: <i>6h</i>
BANHEIRO	<i>1x</i>
TIPO DE RESPIRAÇÃO	<i>nasal</i>
PRÁTICA EXERCÍCIO	<i>Caminhada 15' / Pilates (2x) / 20hs</i>
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:	<i>5</i> ALMOÇO: <i>5</i> LANCHE: <i>5</i> JANTAR: <i>5</i>
IDADE: <i>62</i>	PESO: <i>80</i> IAH: <i>49.5</i> MALLAMPATI: <i>SPO2:</i>
<i>01/02</i>	<i>P = 6.6 cmH₂O</i>
<i>23</i>	<i>APE = 1</i>
	<i>Umidade = 4</i>
<i>03/02</i>	<i>P = 6.6</i>
<i>23</i>	<i>IAH = 3.7 efer</i>
	<i>m. de uso: 7h</i>
	<i>Fiz uma video chamada.</i>
<i>08/02</i>	<i>P = 6.6 cmH₂O</i>
<i>23</i>	<i>IAH = 1.6 efer</i>
	<i>m. de uso: 7h15</i>
	<i>Bem adaptado</i>
<i>23/02</i>	<i>P = 6.6 cmH₂O</i>
<i>23</i>	<i>IAH = 1.3 efer</i>
	<i>m. de uso: 6h23'</i>
	<i>Relata melhora da cansaço.</i>
	<i>Faz exerc. pela manhã.</i>
<i>24/03</i>	<i>P = 6.6 cmH₂O fixo</i>
<i>203</i>	<i>IAH = 1.2</i>
	<i>m. de uso = 6h40 min</i>
	<i>fuga = 28.7</i>
<i>24/05</i>	<i>P = 6.6 cmH₂O</i>
<i>23</i>	<i>IAH = 1.3 efer</i>
	<i>m. de uso: 6h36'</i>
	<i>Bem adaptado.</i>
<i>04/08</i>	<i>P = 6.6 cmH₂O</i>
<i>23</i>	<i>IAH = 1.5 efer</i>
	<i>m. de uso: 6h50'</i>
	<i>Fuga = 0.4 l/min</i>
<i>09/10</i>	<i>P = 6.6 cmH₂O</i>
<i>23</i>	<i>IAH = 1.3 efer</i>
	<i>Fuga = 17.7 l/min</i>
	<i>Bem adaptado.</i>

16/01
24 P = 6,6 cm H₂O
IAH = 0,8 eflu
M. de uso: 7h 21'
Fuga = 17,9 l/min

Bem adaptada, s/ queixas
TROQUEI O PRONG.
fua

22/04
24 P = 6,6 cm H₂O
IAH = 1,3 eflu
M. de uso: 7h 40'
Fuga = 0,4 lpm.

sem queixas

fua

24/06
24 P = 6,6 cm H₂O
IAH = 1,0 eflu
M. de uso: 8h 5'
Fuga: 1,4 lpm.

fua

28/08
24 P = 6,6 cm H₂O
IAH = 1,5 eflu
M. de uso: 7h 37 min
fuga: 21 l/min

Bem adaptada

* troca filtro N30: *
Séria

28/10
24 P = 6,6 cm H₂O
IAH = 1,2 eflu
M. de uso: 7h 30'
fuga = 22,5

Bem adapt. porém másc. vazando
TROCO O PRONG.

fua

27/01
25 P = 6,6 cm H₂O
IAH = 0,8 eflu
M. de uso: 8h 17'

Bem adaptada, s/ queixas.

fua

07/04
25 P = 6,6 cm H₂O
IAH = 1,1 eflu
M. de uso: 7h 43'
fuga = 1,4 lpm.

Bem adaptada, s/ queixas
TROCO O FILTRO DA MÁSC.

fua

CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA
POLISSONOGRAFIA

NOME: Carmen Deia Medeiros Barbosa

EXAME nº: 5205-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Flávio Augusto Passarelli Prado

DATA: 17/10/2022

IDADE: 62 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h46min e concluído às 06h30min. A latência para o sono foi de 6 minutos e a latência para o sono REM, de 193 minutos. O tempo total de sono foi de 319 minutos (05h19min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 80,4%. A distribuição do sono mostrou 12,9% de estágio 1, 48,6% de estágio 2, 28,7% de estágio 3 e 9,9% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 71,5 minutos em vigília, ocorreram 56 microdespertares (índice: 10,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 13,4/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 4/hora, sendo 0 apneia/hora e 4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 82%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,5 cm de H₂O.

Os índices de apneia/hipopneia (4/hora; índice normal até 4/hora) e de distúrbio respiratório (4/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Ocorreram alguns episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. O ritmo cardíaco foi sinusal e as frequências cardíacas foram: mínima: 49; máxima: 63 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 6 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (193 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 80,4%; normal: 85% ou acima), mas o índice de microdespertares (13,4/hora; normal até 15/hora) permaneceu nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (12,9%; normal: 8-10%) e 3 (28,7%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (9,9%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (48,6%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (13,4/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Flavio Augusto Passarelli Prado
OTORRINOLARINGOLOGIA
CRM 100701
Graduação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP
Especializado em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

A Carmen Deia Medeiros Barbosa

Solicito:

- Adaptação de CPAP a pressão sugerida de 6,5cmH2O

G47.3

Dr. Flavio A. P. Prado
Otorrinolaringologista
CRM: 100.701

DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTE

PSIQUIATRIA

CRM-SP 59730

CRM-SP 62853

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Carmen Deia Medeiros Barbosa

EXAME nº: 5205

SOLICITADO POR: Dr. Flávio Augusto Passarelli Prado

DATA: 27/08/2022

IDADE: 62 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h02min e concluído às 06h35min. A latência para o sono foi de 1 minuto e a latência para o sono REM, de 119 minutos. O tempo total de sono foi de 319 minutos (05h19min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 71,3%. A distribuição do sono mostrou 15% de estágio 1, 50,9% de estágio 2, 16,9% de estágio 3 e 17,1% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 127 minutos em vigília, ocorreram 114 microdespertares (índice: 21,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 7,5/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 49,5/hora, sendo 14,9 apneia/hora e 34,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 49,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (49,5/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (49,5/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 48; máxima: 69 bpm.

O ronco foi intermitente e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 1 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (119 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 71,3%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 21,4/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (15%; normal: 8-10%) e 3 (16,9%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (17,1%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (50,9%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (7,5/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 11 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
CRM-SP 59730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730